

- Internal Medicine PE

- 腦膜刺激徵象 (Meningeal Signs)

- * Brudzinski' s sign : 被動屈頸 → 雙膝不自主屈曲 ; 陽性提示腦膜炎、蜘蛛網膜下腔出血
 - * Kernig' s sign : 仰臥屈髖 90° 後伸膝受限或疼痛 ; 陽性提示腦膜刺激

- 上運動神經元徵象 (UMN Signs)

- * Babinski sign : 劃腳底外側 → 大拇趾背屈 + 其餘趾扇形展開 ; 陽性表示 UMN 病變
 - * Hoffman' s sign : 彈中指指甲 → 拇指與食指屈曲 ; 上肢 UMN 病變等效指標

- 小腦 / 平衡功能 (Cerebellar & Balance)

- * Romberg test : 閉眼雙腳併攏站立 → 搖晃為陽性 ; 區分後柱病變 (陽性) vs 單純小腦病變 (睜眼即失衡)
 - * Tandem gait test : 腳跟接腳尖走直線 ; 測試小腦協調與步態穩定性
 - * Finger to nose test : 手指反覆觸鼻 ; 測試上肢小腦協調 (intention tremor、dysmetria)
 - * Heel to shin test : 腳跟沿對側脛骨滑動 ; 測試下肢小腦協調功能

- 腹部徵象 (Abdominal Signs)

- * Courvoisier' s sign : 無痛性黃疸合併可觸及膽囊 ; 提示胰頭癌或壺腹部腫瘤 (非膽石症)
 - * Murphy' s sign : 深吸氣時右上腹觸診引發疼痛致吸氣中斷 ; 提示急性膽囊炎
 - * Peritoneal signs (Rebound tenderness) : 壓放腹部時反跳痛 ; 表示腹膜炎
 - * Psoas sign : 被動伸展右髖引發右下腹痛 ; 提示後位闌尾炎或腰大肌膿瘍
 - * Obturator sign : 被動屈右髖 + 內旋引發右下腹痛 ; 提示盆腔位闌尾炎
 - * Rovsing' s sign : 壓左下腹引發右下腹疼痛 ; 提示急性闌尾炎
 - * Battle' s sign : 乳突後方瘀青 ; 提示顱底骨折 (後顱窩)

- 脊椎 / 脊髓 (Spine & Spinal Cord)

- * Anal wink test : 刺激肛周皮膚 → 肛門括約肌收縮 ; 測試 S2-4 脊髓節完整性
 - * Schober' s test : 標記 L5 上下各 5 cm , 前彎後增加 < 5 cm 為陽性 ; 診斷僵直性脊椎炎 (AS)

- 血液 (Hematology)

- * Coomb' s test : 直接 (紅血球表面抗體) / 間接 (血清游離抗體) ; 診斷自體免疫溶血性貧血、輸血反應、HDN

- OB/GYN PE

- 胎兒評估 (Fetal Assessment)

- * Non-Stress test (NST) : 監測胎動時胎心率是否加速 (reactive = 20 min 內 ≥ 2 次加速 ≥ 15 bpm × 15 sec) ; 評估胎兒儲備能力

- 先天性髖關節脫位篩檢 (DDH Screening)

- * Ortolani test : 屈髖外展時感到彈動感 (clunk) ; 股骨頭「復位」回髖臼, 陽性確認脫位
 - * Barlow test : 屈髖內收加壓 → 股骨頭向後脫出 ; 陽性表示髖關節不穩定 (可脫位)

- NE 評估

- 顱內出血鑑別 (Intracranial Hemorrhage)

類型	影像形態	出血來源	關鍵臨床特徵
EDH (硬膜外)	雙凸鏡形、 不跨縫	中腦膜動脈 (顳骨骨折)	清醒期 (lucid interval) 後急速惡化
SDH (硬膜下)	新月形、 跨縫	橋接靜脈撕裂	急性／慢性；老人、酒精濫用高風險
SAH (蜘蛛網膜下)	腦池積血	動脈瘤破裂	雷擊頭痛 (worst headache of life)；腦膜刺激陽性
ICH (腦內出血)	深部圓形血腫	穿通小動脈 (高血壓)	基底核、視丘、橋腦好發；抗凝血劑為另一大原因
Subgaleal hemorrhage	頭皮下瀰漫腫脹、 跨縫跨囟	導靜脈撕裂	新生兒 (產鉗/真空吸引)；可大量失血致休克